

Trombocitopenias

Bibliografía 2019 – Hospital Perrupato – Dr. Navarro David
Pediátrics Agosto 2012 – PRONAP 2004

“Número de plaquetas inferior a 150.000/mm³”

Clasificación:

- **Leve:** <150.000 - >50.000/mm³: hemostasia normal
- **Moderada:** 50.000 – 30.000/mm³: sin síntomas, ni siquiera si presentan traumatismos significativos
- **De riesgo leve:** 30.000 – 10.000/mm³: riesgo de sangrado ante ejercicios bruscos o traumatismos leves
- **De riesgo moderado:** <10.000 – 5.000/mm³: riesgo de hemorragia espontánea, en general, pacientes con petequias y equimosis espontáneas
- **De riesgo grave:** < 5.000/mm³: riesgo de hemorragia espontánea potencialmente mortal

Púrpura Trombocitopénica Idiopática (PTI)

- Enfermedad autoinmune en la cual una respuesta inmune inadecuada (pérdida de tolerancia a los auto-antígenos), inducida por virus u otros agentes aun desconocidos, da como resultado la presencia de autoanticuerpos que reaccionan con las plaquetas.
- Las plaquetas sensibilizadas con anticuerpos son removidas de la circulación por los macrófagos del sistema reticuloendotelial (SRE) en el bazo y otros órganos.
- La heterogeneidad de la enfermedad sugiere tanto influencias genéticas como ambientales.
- El antecedente de infección viral o inmunización con vacuna a virus vivos atenuados ocurridos en las 4 a 6 semanas precedentes al comienzo de la sintomatología, puede ser detectado en aproximadamente el 50% de los casos.

Sobre nuestra serie de 819 casos, el antecedente en el

- 73%: infecciones respiratorias agudas
 - 11% vacuna a virus vivos atenuado (sarampión, parotiditis y rubeola)
 - 10,5% a enfermedades virales reconocibles (rubéola, sarampión, etc.)
 - 10% a otros cuadros infecciosos
- Púrpura 2° en frecuencia en pacientes pediátricos (1°: púrpura de S. Henoch)
 - Máxima incidencia: 2-5 años y sobre todo en meses de la
 - Primavera

Criterios diagnósticos

Deben estar presentes los **cuatro requisitos** siguientes:

A. Síndrome purpúrico con trombocitopenia (recuento plaquetario menor de 150.000/mm³).

B. Ausencia de enfermedad infecciosa aguda concomitante (mononucleosis infecciosa, hepatitis, etc.).

C. Ausencia de patología sistémica de base (colagenopatía, linfoma, infección por VIH, etc.).

D. Megacariocitos normales o aumentados en médula ósea (este requisito puede ser reemplazado por la ocurrencia de remisión espontánea completa en aquellos pacientes a los que no se les haya realizado punción de médula ósea).

Clasificación

- De resiente diagnóstico: hasta 3 meses
- Persistente: >3 – 12 meses
- Crónica: > 12 meses

Cuadro clínico

Aparece de forma abrupta con la presencia de manifestaciones hemorrágicas en un niño previamente sano.

En un pequeño número de pacientes, principalmente los mayores de 9 años, los síntomas van apareciendo insidiosamente.

En un mínimo número se detecta como un hallazgo en algún análisis.

Manifestaciones hemorrágicas cutáneas > 90% de los casos

Le siguen en orden de frecuencia el sangrado por mucosas:

- Epistaxis
- Hemorragia digestiva
- Hematuria y metrorragia

Hemorragia intracraneal: > grave (0.5 – 1%)

Tenerse en cuenta el sangrado intrabdominal, especialmente después de algún traumatismo.

En general los síntomas de sangrado se van atenuando luego de transcurridos los primeros días de enfermedad.

Examen físico:

- Paciente en BEG
- Petequias alrededor de zonas de presión: cara, cuello y parte superior del tórax
- Sangrado de mucosas
- En general no hepato-esplenomegalia
- Habitualmente no hay linfadenopatías significativas
- Evaluar siempre el SNC (sangrado intracraneal)

Plan de estudios diagnóstico

Hemograma completo

- Recuento plaquetario y volumen plaquetario medio
- Frotis: habitualmente macro y/o megaplaquetas circulantes

PMO: El hallazgo de una médula ósea normal, con megacariocitos en cantidad normal o aumentada, confirma el diagnóstico.

Realizarse cuando:

- A los 15 días el recuento plaquetario persiste en valores similares a los del momento del diagnóstico
- La trombocitopenia persiste más de 6 meses
- Siempre antes de indicar corticoides

Queda a criterio del médico cuando:

- El RP experimenta un aumento parcial
- El paciente presente hemorragias severas

Coagulograma

Signos de hemólisis: prueba de Coombs directa (si es + sospechar enfermedad autoinmune)

Serología viral:

- Epstein Barr
- VIH
- Citomegalovirus
- Hepatitis

Estudio de collagenopatía

Realizar en todo paciente mayor de 10 años.

En pacientes menores solo si existen otros signos clínicos o de laboratorio que hagan sospechar su existencia

Orina completa (hematuria?)

Sangre oculta en materia fecal (puede pedirse como RPMN en MF)

Criterios de internación

- Trombocitopenia < 20.000
- Hemorragias activas:
 - Epistaxis
 - Hemorragia GI
 - Inyección conjuntival (sospechar hemorragia del SNC)
- Indicación de realizar PMO
- < 2 años con transfusiones repetidas

Tratamiento

- **Emergencia; hemorragias de riego vital (<10.000 plaquetas):**
 - Transfusión continua de plaquetas a 1UI/Kg/hora
 - Inmunoglobulina EV por 1-2 días a 1g/Kg/día
 - Esplenectomía de urgencia
 - Cirugía en sitios de sangrado si fuera necesario y factible (SNC, abdomen)
- **RP <15.000/mm³:**
 - **Corticoides:** su mecanismo de acción es multifactorial, se basa fundamentalmente en la inhibición de la eliminación de las plaquetas recubiertas por anticuerpos por parte del Sistema Retículo Endotelial
 - Esquema: Prednisona VO, 1 a 2 mg/kg/día, durante 3 a 4 semanas o a dosis de 4 a 6 mg/kg/día durante 4 días consecutivos; de esta forma, se evitan los efectos colaterales de la administración prolongada.
 - Otra opción: Inmunoglobulina G EV
- **RP 30.00 – 50.000:**
 - IDEM anterior si requieren intervención quirúrgica
- **Medidas generales tendientes a disminuir el riesgo de hemorragias severas:**
 - Prohibir la realización de deportes de contacto
 - Prohibir la ingesta de aspirina y otros medicamentos antiagregantes o anticoagulantes
 - Evitar las inyecciones intramusculares y administrar vacunas (sobre todo con recuentos < 50.000)
 - Suspender los tratamientos de desensibilización alérgica (por la inyección y su acción sobre los mecanismos inmunológicos regulatorios)

Conducta expectante, de observación estricta y no intervención a menos que se detecten factores considerados de riesgo

Tratamiento de la PTI crónica

1. Mantener iguales medidas generales que en la PTI aguda
2. Seguimiento por Hematología
3. Conducta expectante con observación estricta
4. Corticoides a dosis altas
5. Esplenectomía: < 20.000 plaquetas
6. Tratamiento sintomático
7. Última alternativa: Terapia inmunosupresora

Evolución

Remisión según grupo etario:

2 – 12 meses: 84,4%

1 – 10 años: 67,8%

> 10 años: 47,3%

El 50% de los pacientes que remiten lo hacen dentro de las primeras 4 semanas, y a los 4 meses ya ha alcanzado remisión el 93%.

El resto (30% de total de los pacientes), evoluciona a **PTI persistentes/crónica**, esta forma presenta un comportamiento muy polimorfo, oscilando entre los que presentan hemorragias severas y/o frecuentes a aquellos totalmente asintomáticos. En el 50% de los pacientes no esplenectomizados se observa remisión antes del 12º mes.

Trombocitopenia por disminución en su formación (mielodepresión)

1. Infecciosa:
 - Causa más frecuente de trombocitopenia transitoria
 - Además de la mielodepresión hay destrucción acelerada por el sistema inmune
 - Etiología:
 - Epstein - Barr
 - CMV
 - Parvovirus
 - Varicela
 - Rickettsia

2. Cardiopatía cianótica
3. Insuficiencia e infiltración medular: en general hay pancitopenia, la etiología más frecuente es la leucemia linfoblástica aguda (leucemia + fr en niños)
4. Carencia nutricional: déficit de Ac fólico, B12 o hierro
5. Defectos congénitos

Trombocitopenia neonatal autoinmune

1. Trombocitopenia neonatal autoinmune

- Se produce por pasaje transplacentario de Ac antiplaquetarios
- En general el primer embarazo es afectado y es más grave que el 2°
- Riego más grave (10%) de hemorragia intracraneal intrauterina
- En general plaquetas <10.000
- Es autolimitada

2. Enfermedades autoinmunes

- En general hay pancitopenia
- Más frecuente en niños >

3. Anticuerpos inducidos por fármacos

- Hay resolución en aproximadamente 7 días luego de suspender el fármaco
- Ejemplos:
 - Heparina
 - Carbamacepina
 - Fenitoina
 - TMS
 - Vancomicina
 - Ácido valproico

Trombocitopenias por destrucción: en el frotis se observan plaquetas > tamaño

1. CID
2. SUH
3. Destrucción mecánica:
 - Hemodiálisis
 - Circulación extracorpórea
 - Transfusión sanguínea

Trombocitopenia por secuestro

- Hiperesplenismo por hipertensión portal o paludismo
- Puede acompañarse de pancitopenia

